

Logística Hospitalar

EDMUNDO SOUZA



Unidade 4

Livro Didático
Digital



Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial
ANDRÉA CÉSAR PEDROSA

Projeto Gráfico
MANUELA CÉSAR ARRUDA

Autor
EDMUNDO SOUZA

Desenvolvedor
CAIO BENTO GOMES DOS SANTOS

O AUTOR

Edmundo Souza

Olá. Meu nome é Prof. Edmundo Souza. Sou formada em Administração Hospitalar, com uma experiência técnico-profissional na área de Gestão Administrativa, Compras e Suprimentos, mais de 25 anos. Passei por empresas como a Amil, Hospital São Camilo, Grupo Hemocentro São Lucas, Hospital e Maternidade Voluntários. Como professor de cursos superiores e pós-graduação, mais de 12 anos. Passei por empresas como Anhanguera Educacional, FMU, Laureate International Universities e SENAC. Atualmente trabalho no Departamento de Compras e Suprimentos do GNDI-Grupo NotreDame Intermédica e também sou Tutor EAD da UNIP. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Meu nome é Manuela César de Arruda. Sou a responsável pelo projeto gráfico de seu material. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



INTRODUÇÃO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;



EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;



ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;



IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;



RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Logística interna hospitalar	11
Evolução da logística.....	13
Logística no segmento hospitalar.....	16
Processo de aquisição e sua importância	21
A função da área de compras.....	21
Processo de compra.....	24
Fornecedores.....	26
Seleção de materiais e medicamentos.....	28
Logística e suprimentos	32
Recebimento e armazenamento	36
Armazenamento.....	38
Formas de armazenamento de materiais.....	40
Armazenamento de medicamentos.....	41
Armazenamento de medicamentos termolábeis	42

UNIDADE

04

INTRODUÇÃO

Sabemos que o principal objetivo de uma organização de saúde é oferecer um atendimento eficiente aos pacientes. Entretanto, uma logística e gestão incorretas podem impedir que esse objetivo seja alcançado.

O processo de logística hospitalar é uma teia, ou seja, para que o objetivo seja alcançado, a gestão e a logística devem funcionar em conjunto. Isso traz um impacto positivo para o equilíbrio financeiro da instituição e para a segurança à saúde dos pacientes.

Com as novas tendências tecnológicas na saúde, tudo tende a ser realizado de maneira mais tranquila, através da automatização. Um software ou as ferramentas de gestão tendem a trazer mais segurança que significam mais vantagens para a instituição

Além disso, é bom ressaltar a importância de investir numa equipe de gestão capacitada e bem treinada. Não adianta possuir os melhores e mais modernos softwares se os profissionais não estão preparados para utilizá-los.. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 4**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

- 1.** Conhecer os princípios básicos da Gestão Hospitalar.
- 2.** Compreender as estruturas e funções administrativas da Gestão Hospitalar.
- 3.** Compreender a gestão da cadeia de suprimentos no âmbito hospitalar.
- 4.** Identificar, analisar e compreender a estrutura da logística hospitalar.

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? Ao trabalho!

Logística Interna Hospitalar



OBJETIVOS

Esta unidade busca descrever a função de logística interna e a logística reversa na cadeia hospitalar. Por intermédio da descrição da logística do departamento de suprimentos de um hospital é possível discutir os principais objetivos ligados ao departamento de compras, ao recebimento de medicamentos e materiais e os métodos de dispensação mais adequados para cada tipo de hospital ou departamento. Então vamos lá. Avante!

A Logística Hospitalar tem por finalidade assegurar o abastecimento de forma contínua dos insumos para assim atender as necessidades dos setores produtivos, administrar todos os problemas relacionados a suprimentos, tudo aquilo que represente investimento de capital de uma organização. Para que isso ocorra deverá exercer fiscalização e controle efetivo visando a pontualidade no abastecimento, para assim vislumbrar maior produtividade (PATERNO, 1990).

De acordo com Pereira et al, (2005), a farmácia hospitalar e o departamento de suprimentos movimentam um volume de capital somente inferior à folha de pagamentos de um hospital, motivo pelo qual os administradores desses setores deverão sempre zelar pela pontualidade, pelo menor tempo de giro de estoque possível e máximo prazo para pagamento dos materiais e medicamentos com o objetivo de reter o mínimo possível do capital de giro nas prateleiras da farmácia ou almoxarifado, bem como dos subestoques em enfermarias e centros cirúrgicos. Os principais e mais utilizados sistemas de distribuição de medicamentos existentes são: o coletivo, o individualizado e o sistema por dose unitária.

A característica principal do sistema coletivo é fazer a solicitação de medicamentos e materiais pelos departamentos, setores, enfermagem, centro cirúrgico e unidade de terapia intensiva, baseada na transcrição médica e dispensados a estes setores em suas embalagens originais

usualmente por períodos longos que variam de uma semana até 15 dias ou mais. Na maioria das vezes, o sistema coletivo gera subestoques nesses locais, assim, aumentam as perdas por validade e devoluções à farmácia. (MALIK e SCHIESARI 2002).

Conforme os autores citados no sistema individualizado, a característica principal é que as solicitações são feitas em nome de cada paciente e dispensadas em suas embalagens originais ou de forma fracionada, desde que estas sejam muito bem identificadas e seja possível sua rastreabilidade. Os medicamentos sólidos orais são os mais comumente fracionados pela facilidade, já os líquidos e suspensões também podem ser fracionados, porém exigem maior estrutura da farmácia em razão do grau de dificuldade. Assim, a coordenação do processo deve ser feita pela farmácia, visando a maior segurança. Existem duas variações do sistema individualizado: direto e indireto. No sistema individualizado indireto, é levada à farmácia a transcrição da prescrição. Já no sistema individualizado direto, a cópia da prescrição é entregue à farmácia, diminuindo possíveis erros em sua transcrição. (MALIK e SCHIESARI, 2002).



Fonte: Freepik

Não basta distribuir e dispensar bem os medicamentos e materiais é preciso também comprar bem, receber bem e armazenar bem, evitando excesso de estoques, perdas por validade e armazenamento inadequado. O trabalho de logística é contínuo, pode sempre ser aprimorado e qualquer atitude por menor que possa parecer pode significar grande economia a médio e longo prazos (BARBIERI e MACHLINE, 2006).

Evolução da logística

A origem do termo vem do grego "LOGÍSTICOS", do qual o latim "LOGISTICUS" é derivado, ambos significando cálculo e raciocínio no sentido matemático. O desenvolvimento da logística está intimamente ligado ao progresso das atividades militares e das necessidades resultantes das guerras. Uma das grandes lendas na Logística, que inspirou outros grandes líderes como Júlio César e Napoleão e que, até hoje, inspira as grandes empresas, foi Alexandre o Grande, da Macedônia. Seu império alcançou diversos países, incluindo Grécia, Pérsia e Índia. Nascido em 356 a.C., aos 16 anos já era general do exército macedônico e aos 20 anos, com a morte de seu pai, assumiu o trono. Seu império durou apenas 13 anos, até a sua morte em 323 a.C., aos 33 anos. Seu sucesso não foi um acidente, pois foi capaz de superar os exércitos inimigos e expandir seu reinado graças a fatores como: inclusão da logística em seu planejamento estratégico, detalhado conhecimento do exército inimigo, dos terrenos de batalha, dos períodos de fortes intempéries, inovadora incorporação de novas tecnologias de armamentos, desenvolvimento de alianças, manutenção de um simples ponto de controle, que centralizava todas as decisões que eram o ponto central do controle que gerenciava o sistema logístico incorporando-o ao sistema estratégico (TIGERLOG, 2006). Alexandre foi o primeiro a utilizar uma equipe especializada de engenheiros e contramestres que, entre outras funções, seguiam à frente das tropas comprando todos os suprimentos necessários, montando armazéns avançados no trajeto. O exército de Alexandre consumia 300.000 litros de água e 100 toneladas de alimentos diários (TIGERLOG, 2006).

Por volta de 1670, um conselheiro do Rei Luís XIV sugeriu a criação de uma nova estrutura de suporte para solucionar os crescentes problemas administrativos experimentados com o novo exército desenvolvido a partir do caos medieval. Assim foi criada a posição de "Marechal General de Logis", cujo título originou-se do verbo francês "loger", que significa alojar. Entre seus deveres, estavam a responsabilidade pelo planejamento das marchas, seleção dos campos e regulamentação do transporte e fornecimento (TIGERLOG, 2006).



IMPORTANTE

No início de 1991, o mundo presenciou o que se pode rotular de um exemplo da importância da logística. Precedente à Guerra do Golfo os Estados Unidos da América e seus Aliados precisaram deslocar para mais de 12000 km de distância meio milhão de pessoas, mais de 2,3 milhões de toneladas de equipamentos, um número igualmente grande de suprimentos por vias aérea e marítima, tudo isso em poucos meses (TIGERLOG, 2006).

Os militares entenderam o significado e a importância da logística, mas só em um passado recente, as organizações não-militares reconheceram o verdadeiro peso que o gerenciamento logístico pode representar na obtenção da vantagem competitiva. Isso se deve em parte ao baixo nível de compreensão dos benefícios da logística integrada. Os princípios logísticos levaram mais de setenta anos para que fossem claramente definidos (TIGERLOG, 2006).

Existem muitas definições para a logística, mas o conceito principal poderia ser:

A logística é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, peças e produtos acabados (e fluxos de informações correlatas) através da organização e seus canais de marketing, de modo a poder maximizar as lucratividades presente e futura através do atendimento dos pedidos a custo baixo" (CHRISTOPHER, 2002).

No Brasil, a história da logística é ainda muito recente e podem ser destacados alguns fatos descritos abaixo, segundo Tigerlog, (2006):

Anos de 1970:

- desconhecimento do termo e da abrangência da logística;
- informática ainda era um mistério e de domínio restrito;
- iniciativas no setor automobilístico, sobretudo nos setores de movimentação e armazenagem de peças e componentes em função da complexidade de um automóvel que envolvia mais de 20.000 itens diferentes;
- fora do segmento automobilístico, o setor de energia elétrica definia normas para embalagem, armazenagem e transporte de materiais;
- em 1977 são criadas a ABAM - Associação Brasileira de Administração de Materiais e a ABMM - Associação Brasileira de Movimentação de Materiais, que não se relacionavam e nada tinham de sinérgico;
- em 1979, é criado o IMAM - Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais

Anos 1980:

- em 1980, surge o primeiro grupo de Estudos de Logística, criando as primeiras definições e diretrizes para diferenciar Transportes de Distribuição e de Logística;
- em 1982, é trazido do Japão o primeiro sistema moderno de logística integrada, o JIT - Just in Time e o KANBAN, desenvolvidos pela Toyota;
- em 1984, é criado o primeiro Grupo de Benchmarking em Logística;
- em 1984, a ABRAS - Associação Brasileira de Supermercados cria um departamento de logística para

discutir e analisar as relações entre Fornecedores e Supermercados;

- é criado o Pálete Padrão Brasileiro, conhecido como PBR e o projeto do Veículo Urbano de Carga;
- em 1988, é criada a ASLOG - Associação Brasileira de Logística;
- instalação do primeiro Operador Logístico no Brasil (Brasildock's)
- estabilização da economia a partir de 1.994 com o plano Real e foco na administração dos custos;
- evolução da microinformática e da Tecnologia de Informação, com o desenvolvimento de software para o gerenciamento de armazéns como o WMS - Warehouse Management System, códigos de barras e sistemas para Roteirização de Entregas;
- entrada de 06 novos operadores logísticos internacionais (Ryder, Danzas, Penske, TNT, McLane, Exel) e desenvolvimento de mais de 50 empresas nacionais;
- privatização de rodovias, portos, telecomunicações, ferrovias e terminais de contêineres;
- investimentos em monitoramento de cargas.
- ascensão do e-commerce.

Logística no segmento hospitalar

Em 1972, foi assinado um convênio entre a Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Este projeto, denominado PROAHSA – Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde, vem desde então ministrando cursos de especialização e mestrado strictu sensu, destinado

a profissionais da área da saúde, bem como realizando pesquisas e consultorias no setor (BARBIERI e MACHLINE, 2006).

O mesmo autor cita que a logística dos materiais assume grande importância no segmento. O elevado custo de manutenção de estoques de um lado e a necessidade de proporcionar um excelente nível de atendimento aos pacientes do outro, sem a ocorrência de qualquer alta de insumos requer grande proficiência do gestor de materiais. Com o preço cobrado do paciente ou convênio fixado, a redução de custos na compra de materiais e medicamentos que o hospital privado pode esperar obter lucro e o hospital público equilibrar seu orçamento.



Fonte: Freepik

Para Paterno (1990), a importância da logística dos materiais no hospital é importante, pois assegura ao mesmo o reabastecimento racional dos materiais necessários a manutenção dos fluxos de seu ciclo operacional e é importante quando leva o Administrador ao exercício de uma série de atitudes administrativas mais específicas, tais como:

- prever quantidades e qualidades;
- prever sistemas de reposição de materiais;
- adquirir, minimizando custos;
- armazenar, estocando técnica e funcionalmente;
- conservar, protegendo contra a deterioração, avarias e obsolescência;
- controlar entradas, saídas e saldos;
- prover, com distribuição rápida e econômica;
- atuar com dinamismo e segurança.

Para Paterno (1990), vale destacar a importância das classificações mais vitais de materiais (como XYZ, ABC, estratégicos, entre outros) nos quais são enfatizados custos e receitas preponderantes, na compra, na venda ou no aspecto de criticidade ao faltarem ou as razões técnicas e humanas (e não econômicas) de estarem em estoque no hospital.

Conforme Dias (1993), para implantar melhoramentos na estrutura industrial é preciso dinamizar o Sistema Logístico, que engloba o suprimento de materiais e componentes, movimentação e controle dos produtos, até a colocação do produto acabado no consumidor, o que analiticamente no segmento hospitalar pode significar suprimento de materiais e medicamentos, movimentação e controle desses até a dispensação.

Segundo Paterno (1990), a administração da logística de materiais em um hospital “compreende um ciclo continuo de operações correlatas e interdependentes que são”:

- previsão;
- aquisição;
- transporte;
- recebimento;

- armazenamento;
- distribuição;
- conservação;
- venda de excedentes e análise e controle de inventários.

Paterno (1990), define que administração de materiais deve ser entendida como um ramo da Administração que trata, especificamente, dos materiais necessários ao funcionamento do hospital para a produção de bens e serviços. Por materiais, entende -se aqui todos os itens contabilizáveis do almoxarifado, da farmácia e da despensa de um hospital que participa "diretamente" na constituição de um bem ou serviço e os demais, cuja participação é apenas indireta, mas, que fazem parte da rotina diária do hospital como material de escritório, material de conservação e reparos, material de segurança, entre outros.

As atividades voltadas para administrar o fluxo de materiais e de informações, ao longo da cadeia de suprimento, constituem o que genericamente se denomina LOGÍSTICA. Uma cadeia de suprimentos é um conjunto de unidades produtivas unidas por um fluxo de materiais e informações com o objetivo de satisfazer as necessidades de usuários ou clientes específicos (BARBIERI e MACHLINE, 2006).

Os autores citados referem que a gestão adequada de materiais afasta do hospital três graves males: a compra cara, o estoque excessivo e a falta de material. Estes flagelos são, os dois primeiros, fatais ao hospital e, o terceiro, fatal para o paciente.

De acordo com uma definição do Council of Logistics Managements, já amplamente conhecida, logística é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e economicamente eficaz de matérias-primas, materiais em processo, produtos acabados e informações relacionadas com essas atividades, desde o ponto de origem até o de consumo, com o objetivo de atender às exigências dos clientes. A logística atua em todo o fluxo, desde fornecedores até a entrega dos produtos aos clientes externos à organização, incluindo a prestação

de serviços, pós-venda e pós-entrega, como a assistência técnica e a prestação de serviços de garantia (BARBIERI e MACHLINE, 2006).

Processo de Aquisição e sua Importância



OBJETIVOS

Neste capítulo você vai compreender que a administração de compras é uma atividade fundamental para uma gestão eficaz e que influencia diretamente nos seus estoques e no relacionamento com os clientes, estando também relacionada à competitividade e ao sucesso da organização.

A função da área de compras

A área de compras tem por objetivo processar as aquisições de bens que a organização necessita. O termo compra será aqui entendido como uma das funções da gestão de materiais ou de suprimento que envolve as seguintes famílias de atividades: seleção de materiais, gestão de estoque, compras e armazenagem. A área de compras funciona como um elo entre a organização e seu mercado fornecedor, esta área cuida da aquisição de bens patrimoniais e da contratação de serviços relacionados a esses bens, como: inspeção e manutenção (BARBIERI e MACHLINE, 2006).

Para Paterno (1990), compra é um serviço que tem a finalidade de prever os materiais necessários ao hospital, planejar as quantidades corretas e satisfazê-las no momento certo, na melhor qualidade e ao menor custo.

De acordo com Barbieri e Machline (2006), o termo compra deve ser entendido como uma das funções da gestão de materiais ou de suprimentos e que a administração de materiais envolve as seguintes famílias de atividades: seleção de materiais, gestão de estoques, compras, e armazenagem. A área de compras funciona como um elo entre a organização e seu mercado fornecedor.



Fonte: Freepik

Para Cavallini e Bisson (2002), a função compras é um segmento essencial do departamento de materiais ou suprimentos. Sua finalidade é suprir as necessidades de materiais ou serviços, planejá-las quantitativamente e satisfazê-las no momento certo e na quantidade correta. É importante salientar que, nas modernas organizações hospitalares, essa função pode e deve ser exercida por um farmacêutico ou pessoas da área administrativa, gabaritadas para a atividade e com ampla experiência.

Para Maia Neto (2005), a aquisição de qualquer produto deve ser compatível com as reais necessidades do hospital. Existem hospitais que fazem suas próprias compras. Outros adquirem seus produtos por meio de uma Central de Abastecimento Farmacêutico, quando o hospital é parte de uma instituição quando as compras são centralizadas. Estes fatos não devem mudar em nada os princípios da aquisição.

Maia Neto (2005) cita que a qualidade da matéria-prima, medicamentos e demais produtos a serem adquiridos deve estar em primeiro lugar. Para tanto, devem ser avaliadas a idoneidade dos

laboratórios farmacêuticos e demais fornecedores. Considera-se a qualidade como fator primordial pelo fato de que produtos com qualidade inferior, muitas vezes, tornam-se mais onerosos e prejudiciais, portanto, além de evitar riscos, a economia pode ser uma constante na compra de produtos de qualidade superior.



IMPORTANTE

Na visão do comprador moderno, comprar bem significa o menor custo em produtos de alta qualidade, o fornecedor deve entregar o pedido com pontualidade e de forma completa. É de responsabilidade do departamento de compras com base nos itens que oneram a organização tanto sob a forma de custo direto como sob a forma de margens reduzidas de lucro, buscar no mercado alternativas que atendam a demanda com melhores resultados operacionais e reflitam isto na saúde financeira da organização. (FERRACINE e BORGES FILHO, 2005).

Os autores citam que, também faz parte das responsabilidades do departamento de compras a manutenção atualizada do cadastro de fornecedores por gerar informações que complementem o cadastro dos itens do estoque. O desenvolvimento de novos fornecedores, sua avaliação sistemática, o acompanhamento por meio de indicadores financeiros são funções importantes do departamento de compras. Podemos dizer que a administração adequada desse departamento sustenta a organização, gerando melhores margens ou redução de despesas.

Segundo Dias (1993), os objetivos básicos de uma seção de compras são:

- Obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de produção;
- Coordenar este fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa;
- Comprar materiais e insumos aos menores preços obedecendo a padrões de qualidade e quantidade definidos e

- Procurar dentro de uma negociação justa e honesta as melhores condições para a empresa, sobretudo as condições de pagamento.

Paterno (1990), conceitua o departamento de compras com relação a objetivos de forma semelhante a Dias (1993), acrescentando os itens abaixo:

- Manter boas relações comerciais com fornecedores, assegurando a boa atuação dos mesmos com relação a prazos de entrega e condições de pagamento;
- Desenvolver novas fontes de suprimento (novos produtos e novos fornecedores), tendo em vista o aprimoramento dos procedimentos e métodos de uma política de compra dinâmica e eficaz;
- Adotar uma política de negociações sólida, capaz de enfrentar problemas de variações econômicas, reajustes, aumento de preços, etc.
- Elaborar e manter atualizados cadastros de produtos e fornecedores.

Processo de compra

O processo de compra varia de acordo com o tipo de compra a ser efetuada: compras de itens padronizados, compras de emergência e compras de itens não padronizados (BARBIERI e MACHLINE, 2006).

Para Paterno (1990), o processo de compra é marcado por dois momentos distintos: o tempo de processamento interno e o tempo de processamento externo do pedido.

Ainda, segundo Paterno (1990), o tempo de processamento interno do pedido pressupõe a escolha do fornecedor, negociação, a emissão e entrega do pedido ao fornecedor. O processamento externo do pedido pressupõe a preparação da mercadoria, emissão de notas fiscais e transporte dos materiais até o hospital.

Solicitação de compras e pedido de compras

Solicitação de compras é um documento que dá autorização para o comprador executar uma compra, seja de materiais produtivos ou improdutivos, ela é solicitada para um programa de produção, para um projeto que se está desenvolvendo, ou ainda, para abastecimento geral da empresa. Deve informar o que se deve comprar em que quantidade, o prazo de entrega, o local de entrega e, em alguns casos, especiais os prováveis fornecedores (DIAS, 1993).

Pedido de Compra é um documento formal que deve reproduzir as condições negociadas entre as partes, tendo força de contrato, quando aceito pelo fornecedor. Ele estabelece obrigações e direitos entre comprador e fornecedor, sendo a base para dirimir qualquer dúvida ou controvérsia. Cada pedido deve ter um número, data de emissão, especificação dos itens citados, quantidades, preço unitário, condições de pagamento e reajuste se for o caso, prazo de entrega, local de entrega, frequência das entregas, meio de transporte, impostos, e outras informações necessárias para caracterizar a transação (BARBIERI e MACHLINE, 2006).



Fornecedores

São as fontes de suprimento, é toda empresa interessada em suprir as necessidades de outra empresa, no caso do hospital essas necessidades são basicamente materiais, medicamentos e gêneros. Serão escolhidos os fornecedores que procedam corretamente, cumprindo as condições estipuladas, aceitando críticas, reconhecendo erros e imbuídos do espírito sincero de bem servir (PATERNO, 1990).

O autor citado classifica os fornecedores como:

- Tradicionais, aqueles que o hospital costuma transacionar, são os fornecedores de casa.
- Automáticos, normalmente ligados ao suprimento de materiais, automaticamente repostos no estoque.
- Exclusivos, são os fornecedores chamados monopolistas, usualmente pouco preocupados com o comprador; este precisa deles e não eles do comprador.
- Especializados, fabricam materiais especiais e característicos que o hospital poderá ocasionalmente necessitar.

Para Barbieri e Machline (2006), a escolha dos fornecedores deve ser feita dentro do critério de pontualidade, qualidade e quantidades solicitadas, velocidade nas entregas e custo mínimo à organização. Preliminarmente, as empresas fornecedoras devem apresentar provas de sua idoneidade fiscal, demonstrativos contábeis, seus sistemas de gestão de qualidade e ambiental para com as informações comerciais (preço, prazo, condições e etc.) formarem o cadastro preliminar.

Para Paterno (1990), a seleção de fornecedores deve obedecer a quatro fases, a seguir:

- Fase de levantamento, em que se procura atingir todas as possíveis fontes de fornecimento daquele produto;

- Fase de estudo da qualificação, características e vantagens oferecidas pelo fornecedor;
- Fase de negociações e escolha da fonte mais satisfatória para algumas compras como experiência;
- Fase de seleção definitiva para estabelecimento do cadastro de fornecedores.

Para Barbieri e Machline (2006), a seleção de fornecedores exige uma análise multicritério, mesmo nas compras com base no melhor preço e, entre elas, cita de forma não exaustiva, a seguir:

- Assistência técnica;
- Atendimento às compras de emergência;
- Atendimento às normas trabalhistas;
- Capacidade de inovação;
- Certificações de segunda e terceira parte;
- Consumo de energia;
- Devoluções de produtos vencidos;
- Disponibilidade de estoques para pronta entrega;
- Divergências anteriores;
- Especificações do produto;
- Facilidade de manutenção;
- Flexibilidade para efetuar mudanças nas condições iniciais do pedido;
- Nível de atendimento;
- Pontualidade nas entregas anteriores;
- Prazo de entrega;
- Prazo de pagamento;

- Preço;
- Prestação de informações no processo de compra;
- Promoção do comércio justo;
- Qualidade;
- Reputação do fornecedor;
- Saúde financeira;
- Sistema de gestão de qualidade;
- Sistema de gestão ambiental;
- Sistema de segurança e saúde no trabalho;
- Status da conformidade com a legislação de defesa do consumidor;
- Status de licenciamento e demais exigências ambientais;
- Status dos registros nos órgãos competentes, como no caso de medicamentos, equipamentos individuais de proteção, saneantes e alimentos processados.

Seleção de materiais e medicamentos

Administração de materiais em uma organização objetiva disponibilizar o material certo na quantidade certa no tempo certo para seu usuário. Quanto maior for o número de itens utilizados para dar suporte as atividades, maior se torna a importância da administração de materiais para que a empresa possa atingir a esses objetivos. Em organizações hospitalares que operam com até sete mil itens de materiais, pode-se dizer que a escolha dos mesmos é tão importante que não pode ficar a cargo dos usuários de materiais nem dos administradores de materiais. Isso é válido para qualquer organização, e mais ainda para os hospitais onde uma parcela considerável dos materiais deverá ser selecionada considerando as suas características intrínsecas em face das condutas médicas adotadas. (BARBIERI, 2006)

Barbieri e Machline (2006), consideram que a seleção dos materiais que será utilizada pela organização deve ser efetuada de forma a explicitar as divergências e alcançar um razoável consenso entre os diferentes profissionais envolvidos: usuários, compradores, farmacêutico, almoxarife e diretor financeiro. Esse acordo tem o apoio de um comitê interfuncional criado por instrumento normativo formal (Portaria, Resolução ou qualquer outro documento normativo) com o objetivo de selecionar os materiais mais adequados à organização e a seus diversos usuários. Para escolher os materiais de acordo com as considerações expostas, é preciso realizar em bases sistemáticas as seguintes atividades: especificação, simplificação, padronização, classificação, codificação e catalogação

Nos hospitais o uso racional de medicamentos vem aumentando gradativamente ao longo dos anos. A racionalização traz diversos benefícios, tais como: a redução do tempo de hospitalização e a diminuição de gastos na instituição hospitalar. A política de racionalização dos medicamentos deve ser implementada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), portanto torna-se essencial a elaboração de uma seleção desses produtos (FERRACINI e BORGES FILHO, 2005).

A seleção de medicamentos é uma atividade técnico-científica aplicada na escolha dos medicamentos que atendam a maioria das patologias tratadas no hospital, visando o seu uso racional. Esta seleção, iniciou-se com uma simples lista de medicamentos denominada formulário, evoluiu para um complexo sistema que hoje funciona como um guia para a prescrição médica, podendo ser apresentado e dividido por classes terapêuticas para facilitar a sua busca (PEREIRA, et al, 2005).



Fonte: Freepik

Por meio desta seleção, obter-se-á a padronização dos medicamentos e materiais cabendo à equipe da farmácia hospitalar o incentivo ao respeito e sua divulgação. A padronização trata-se de um processo dinâmico, contínuo, participativo e multidisciplinar, assegurando ao hospital o acesso aos produtos mais necessários por meio de adoção de critérios de eficácia, segurança, qualidade e custo e da promoção da utilização racional desses fármacos (FERRACINI e BORGES FILHO, 2005).

Cavallini e Bisson (2002), descrevem um modelo de estatuto para a comissão de farmácia e terapêutica (CFT):

Conceito:

"A CFT é a junta deliberativa designada pela diretoria clínica com a finalidade de regulamentar a padronização dos medicamentos utilizados no receituário hospitalar".

Objetivo:

"Padronizar o elenco de medicamentos; divulgar, alterar e elaborar estudos; registrar informações e manter arquivo da documentação pertinente".

Critérios:

1. Padronizar medicamentos pelo nome genérico, conforme a Denominação Comum Brasileira (DCB).

2. Padronizar os medicamentos com um único princípio ativo, excluindo, sempre que possível, as associações.

3. Padronizar de preferência medicamentos que resguardem a qualidade, levando em conta o menor custo de aquisição, armazenamento, dispensação e controle.

4. Padronizar, preferencialmente, formas farmacêuticas que permitam a individualização na distribuição.

5. Padronizar formas farmacêuticas, apresentação e dosagem, considerando:

- a comodidade de administração aos pacientes;

- a faixa etária da clientela;
- a facilidade para cálculo das doses usualmente ministradas;
- a facilidade de fracionamento ou multiplicação de doses.

Cavallini e Bisson (2002), sugerem que a CFT seja constituída de:

- um farmacêutico – Chefe da Farmácia ou farmacêutico por ele indicado, que atuará como membro nato;
- um médico – representante da Clínica Médica;
- um médico – representante da Clínica Cirúrgica;
- um médico – representante da Clínica Médica;
- um médico – representante da Pediatria;
- um médico – presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar ou médico por ele indicado;
- um enfermeiro – chefe de enfermagem ou enfermeiro por ele indicado.

Logística e Suprimentos

Para Martins e Laugeni (2003,) a logística é o processo que integra, coordena e controla: a movimentação de materiais, inventários de produtos acabados e informações relacionadas; dos fornecedores por meio de uma empresa; para satisfazer as necessidades dos clientes, isto é, propiciar que as informações, produtos e insumos sejam distribuídos rapidamente.

A logística empresarial, segundo Ballou (1993), procura estabelecer por intermédio de estudos quais as maneiras mais eficientes para atingir melhor rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores, utilizando para isso o planejamento, a organização e o controle às atividades que envolvem movimentação e armazenagem com o objetivo principal de facilitar o fluxo de produtos.

Para Fleury (1999), a logística integrada trata -se de um instrumento de marketing, uma ferramenta gerencial, que agrega valor à prestação de serviços; deve ser considerada como componente central da estratégia de marketing a ser cumprida pela organização logística.

O processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o consumo, com o objetivo de atender os requisitos do consumidor é denominado Logística (NOVAES, 2001).

Quanto maior for a capacidade de uma organização em gerir os materiais de forma adequada, maior será sua capacidade de oferecer a sua clientela bens e serviços de qualidade e com baixos custos operacionais. Isso vale tanto para às organizações manufatureiras como às que atuam nas áreas de serviço, como as organizações hospitalares. Para o atendimento hospitalar, é necessário evitar o excesso e a falta de materiais, duas situações que prejudicam o bom desempenho da organização, pois geram gastos desnecessários que não agregam valor aos serviços prestados por motivos diversos. A falta de materiais no momento em que é necessário, obriga a organização a incorrer em

gastos adicionais para realizar compras urgentes que, via de regra são mais dispendiosas que as planejadas (BARBIERI e MACHLINE, 2006).

Para os autores citados, o excesso de materiais não é menos nocivo pois, estoques altos consomem recursos que poderiam ser aplicados em outras atividades, sem contar que podem estar remunerando capitais de terceiros, gerando despesas financeiras. Materiais em excesso exigem espaços maiores, elevam as despesas com manuseio e movimentação, aumentam as chances de perdas por perecibilidade e obsolescência. O excesso de material mascara ineficiências do sistema produtivo, perpetuando problemas administrativos e operacionais, tais como: manutenção de equipamentos deficientes, relacionamento conflituoso com fornecedores, pessoal desmotivado e altos índices de absenteísmo. Qualquer estoque, além do necessário, é um desperdício e deve ser combatido.

Barbieri e Machline (2006), citam que a Administração de Materiais e a Logística devem andar juntas, contribuindo para ampliar as condições da organização em atender as necessidades em termos de prazos, custos, qualidade e flexibilidade, obtendo o máximo benefício dos recursos aplicados em materiais, algo que só pode ser alcançado dentro de uma abordagem logística que integre todas as atividades relacionadas com o fluxo de materiais. Esta abordagem envolve administração estratégica e operacional que contempla a totalidade dos fluxos de materiais e das informações correspondentes desde os fornecedores até o atendimento aos usuários finais.



Para Fleury (1999), o ambiente competitivo criado no atual mercado mudou a visão das empresas sobre a logística que passa a ser vista como uma atividade estratégica, gerencial e geradora de vantagem competitiva.

Ainda segundo os autores citados a logística deve ser explorada também como uma ferramenta de marketing estratégico, unindo-se a alta tecnologia, proporcionando melhor gerenciamento das operações logísticas a cada dia mais complexas.



IMPORTANTE

A logística deixou de concentrar esforços somente no fluxo de bens, no canal de distribuição e passou, também, a considerar o fluxo de informações, elemento essencial à sobrevivência das empresas. Informações rápidas e precisas são vitais para os sistemas logísticos que se utilizam sobretudo da tecnologia da informação (TI) para otimizar o tempo e a confiabilidade dessas informações. Os Sistemas de Informação Logísticos ligam as atividades logísticas em processo integrado, em menor tempo, conferindo vantagem competitiva as organizações, promovendo maior integração entre os membros da cadeia de suprimentos do fornecedor ao usuário final (ARAÚJO, 1981).

No âmbito hospitalar, a Logística compõe-se de tudo o que se refere à administração de materiais e sua distribuição física no hospital. Programação das necessidades de cada setor, compras, controle de estoque, recebimento, distribuição, tudo feito de maneira integrada. Somente com o auxílio de tecnologias, como: prontuário eletrônico, códigos de barra e, etc. pode-se conseguir um controle efetivo dos materiais e realizar previsões mais confiáveis e seguras (BARBIERI e MACHLINE, 2006).

Segundo Christopher (2002), considera que o gerenciamento logístico pode proporcionar uma fonte de vantagem competitiva, uma fonte de superioridade duradoura sobre os concorrentes, em termos de preferência do cliente, que pode ser alcançada por meio da logística. As bases do sucesso no mercado são muitas, mas um modelo simples é baseado na trilogia: companhia, seus clientes, seus concorrentes – os três “Cs”.

Ainda segundo o mesmo autor, a fonte de vantagem competitiva é encontrada, primeiramente, na capacidade da organização diferenciar-se de seus concorrentes aos olhos dos clientes e, em segundo lugar, pela sua capacidade de operar a baixo custo e, portanto, com maior lucro.



IMPORTANTE

A vantagem competitiva surge da maneira como as empresas desempenham suas atividades dentro da cadeia de valor. Para obter vantagem competitiva sobre seus concorrentes, as empresas devem proporcionar valor aos clientes desenvolvendo suas atividades de forma mais eficiente que seus concorrentes ou faça com que este valor seja percebido pelo comprador.

Recebimento e Armazenamento



OBJETIVOS

Neste capítulo você vai estudar sobre o recebimento e armazenamento das mercadorias compradas. Avante!

Segundo Paterno (1990), recebimento é o setor da organização com a função específica de receber e proceder a conferência das mercadorias compradas. É uma operação importante que se processa por ocasião do ato da entrega do material comprado, normalmente, é desempenhada por funcionário responsável pela função ou por uma comissão constituída para esse fim.

Para Ferracini e Borges Filho (2005), tudo o que foi negociado, será recebido por meio de requisições por este setor. Os agentes dessa área deverão verificar a quantidade e a qualidade das mercadorias, as condições em que elas foram transportadas e os acordos comerciais acertados na negociação feita pelo departamento de compras. Eles devem também preparar esses produtos para o armazenamento, organizar o fluxo de fornecedores, coordenar as entregas prioritárias, alimentar com informações que serão utilizadas na avaliação de fornecedores e encaminhar os documentos fiscais ao setor financeiro para pagamento aos fornecedores.

Ainda segundo os mesmos autores, nos sistemas informatizados integrados, muitas dessas funções são executadas automaticamente. A importância de receber o material certo, na quantidade correta, e em perfeitas condições é a tarefa chave deste setor.

Para Barbieri e Machline (2006), o recebimento é uma atividade administrativa. A administração dos locais de armazenagem compreende as atividades de recebimento, guarda e distribuição dos bens de consumo aos usuários, bem como o controle físico dos estoques.

Os autores citados apresentam as tarefas do recebimento:

- Verificar por comparação entre a nota fiscal do fornecedor e a cópia do pedido, se os materiais entregues foram, de fato, encomendados no tipo, quantidade e no preço estipulado na nota fiscal;
- Assinar os canhotos das notas fiscais dos fornecedores;
- Verificar se as mercadorias entregues correspondem, na quantidade e no tipo, ao que consta na nota. Esta verificação requer contagem e/ou pesagem rigorosa, de cada item;
- Identificar com etiqueta, códigos ou sinais apropriados, os itens entregues que não estiverem claramente marcados;
- Em documentos apropriados, anotar entregas parciais, em excesso ou discrepâncias;
- Avisar os responsáveis pela inspeção da qualidade das mercadorias entregues;
- Enviar as notas fiscais e outros documentos, pertinentes ao almoxarifado propriamente dito, as mercadorias conferidas, inspecionadas e aceitas;
- Providenciar a devolução de mercadorias defeituosas.

No caso de medicamentos, Barbieri e Machline (2006), citam que entre os itens de verificação por ocasião do recebimento de um lote encomendado encontram-se os seguintes: denominação do produto, quantidade, forma farmacêutica, concentração, número do lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Os quatro primeiros itens devem estar de acordo com o pedido de compra, e o setor de recebimento deve ter em mãos uma cópia.

A conferência de materiais não pode ser precipitada, como, em geral, é desejo dos entregadores. Terá de existir um tempo razoável, de acordo com o volume do material a ser conferido. Não se trata de um ato de desconfiança do comprador, mas um direito que lhe assiste, pois uma vez assinado o canhoto do rodapé de uma via da nota fiscal, dando

como devidamente recebido o material, considera-se comercialmente liquidada a transação por parte da firma fornecedora (PATERNO, 1990).

O setor de recebimento deve dispor de área separada do almoxarifado, onde a mercadoria entregue pelo fornecedor é descarregada e aguarda aceitação. A unidade de material deve situar-se no andar térreo. Plataforma de descarga, onde os caminhões podem encostar, no nível da carroceria (um metro de altura) é um requerimento para facilitar a movimentação dos materiais entregues e o acesso externo deverá ser coberto (BARBIERI e MACHLINE, 2006).

Segundo Maia Neto (2005), para o recebimento de medicamentos, devem existir instruções por escrito, descrevendo com detalhes o recebimento, a identificação e o manuseio dos medicamentos. Elas devem indicar adequadamente os métodos de estocagem e definir os procedimentos burocráticos para com outras áreas da organização.

Ainda, segundo Maia Neto (2005), no ato do recebimento, cada entrada deve ser examinada quanto à sua documentação e fisicamente inspecionada para se verificar suas condições, rotulagem, tipo e quantidade. Se for o caso do recebimento de um produto com mais de um lote de fabricação, ele deverá ser subdividido em quantos lotes forem necessários e estocados dessa forma. Os lotes que forem submetidos à amostragem ou os julgados passíveis de análise, devem ser conservados em quarentena até decisão do controle de qualidade.

Armazenamento

Pela denominação genérica armazenagem ou armazenamento, entende-se as atividades administrativas e operacionais de recebimento, armazenamento, distribuição dos materiais aos usuários e controle físico de materiais estocados. Estas atividades rotineiras em qualquer organização devem ser precedidas por estudos que objetivem localizar adequadamente os pontos de estocagem (farmácia, almoxarifado, depósitos de gêneros alimentícios e outros), a capacidade de armazenamento desses pontos, instalações o equipamento e o layout (BARBIERI e MACHLINE, 2006)



IMPORTANTE

Estes estudos devem ser tratados na fase de projeto das instalações físicas, mas cabe fazer algumas considerações sobre estas questões. Os pontos de estocagem devem se localizar em local controlado do ponto de vista ambiental, por exemplo, com baixa umidade, baixa temperatura, boa ventilação, pisos que não transmitam vibrações, iluminação adequada. Tais precauções devem-se ao fato de que muitos materiais perecem em decorrência das condições de armazenagem, por exemplo, temperatura elevada que favorece a emissão de substâncias voláteis, calor e umidade que favorecem a decomposição bacteriana e outras. A localização e o layout devem facilitar a recepção e a distribuição dos materiais aos solicitantes e ao controle físico dos estoques.



Fonte: Freepik

A administração de materiais dispõe de área de estocagem própria, na qual são guardados em prateleiras, escaninhos, compartimentos classificados e numerados, todos os materiais recebidos e conferidos. O armazenamento dos materiais deve obedecer a normas técnicas com objetivo de eliminar perigos de queda, achatamento, deterioração, explosão, perda, etc. O armazenamento deve ser feito de conformidade com o tipo de material e com o tipo de recipiente adequado. Os materiais deterioráveis devem ser dispostos de maneira que os mais velhos saiam em primeiro lugar (PATERNO, 1990).

Formas de armazenamento de materiais

Segundo Cavallini e Bisson (2002), a dimensão e as características de cada produto vão exigir desde a instalação de uma simples prateleira até complexos sistemas de armações, caixas e gavetas. As formas mais comuns para estocagem são: caixas, prateleiras, racks, empilhamento e refrigeradores.

Ainda segundo Cavallini e Bisson (2002), existem certas características da área de estocagem de medicamentos e correlatos que devem ser seguidas, são elas:

- Local: deve ser seguro e de fácil acesso, evitando-se escadas e subsolo. O ideal é estar no nível da rua e possuir rampa de recebimento de materiais;
- Corredores: o número de corredores depende da facilidade de acesso desejada. Quando a quantidade de materiais for grande, podem ser formadas ilhas com várias pilhas. Mercadorias sobre prateleiras requerem corredores a cada duas filas;
- Pilhas: o topo das pilhas deve ficar um metro, no mínimo, abaixo dos sprinklers contra incêndio, instalados no teto;
- Portas: devem permitir a passagem dos maiores carrinhos de transporte quando cheios;
- Pisos: devem ser lisos e de concreto, para suportar o peso dos materiais estocados e o trânsito de carrinhos cheios;
- Ventilação: o local de estocagem deve ter vãos ou janelas para circulação do ar, ser amplo e sem poeira, deve-se evitar a incidência direta da luz solar;
- Temperatura: a temperatura ambiente deve ser mantida em torno de 20 graus Celsius (com variação de dois graus), com refrigerador (de 4 a 8 graus Celsius) para produtos termolábeis;

- Área Física: hospitais com até 100 leitos: 100 metros quadrados; hospitais com até 200 leitos: 180 metros quadrados; hospitais com até 400 leitos: 350 metros quadrados;
- Área de estocagem: deve conter: área distinta para medicamentos e correlatos, área fechada à chave para psicotrópicos, fácil acesso para funcionários, distribuição racional e adequada, prateleiras amplas claras e espaçadas, iluminação adequada e extintores bem localizados.

Armazenamento de medicamentos

Toda e qualquer área destinada a estocagem de medicamentos deve ter condições que permitam preservar suas condições de uso. Nenhum medicamento poderá ser estocado antes de ser oficialmente recebido nem liberado para entrega sem a devida permissão. Estoques devem ser periodicamente inventariados e qualquer discrepância devidamente esclarecida. Devem, também, ser constantemente inspecionados a fim de verificar qualquer degradação visível, sobretudo nos casos, nos quais os medicamentos ainda estiverem garantidos dentro de seus prazos de validade. Medicamentos vencidos devem ser baixados do estoque e destruídos com registro justificado por escrito pelo farmacêutico responsável, de acordo com o disposto na legislação vigente (MAIA NETO, 2005).



Fonte: Freepik



IMPORTANTE

A estocagem, seja ela em armários, prateleiras, estantes ou estrados deve permitir a fácil visualização para uma perfeita identificação dos medicamentos quanto ao nome do produto, lote e validade. A estocagem nunca deve ser feita em contato direto com o solo nem em local que receba luz solar direta. Essas áreas devem ser livres de pó, lixo, roedores, aves, insetos e quaisquer animais. Para facilitar a limpeza e circulação de pessoas, os medicamentos devem ser estocados no mínimo a um metro das paredes. Embalagens parcialmente utilizadas devem ser fechadas novamente para prevenir perdas e contaminações, indicando eventualmente a quantidade faltante do lado de fora da embalagem. A presença de pessoas estranhas às Centrais de Abastecimento deve ser terminantemente proibida nas áreas de estocagem (MAIA NETO, 2005).

Armazenamento de medicamentos termolábeis

Para Maia Neto (2005), os medicamentos que não podem sofrer variações excessivas de temperatura, além das recomendações e cuidados pertinentes à estocagem de outros tipos de medicamentos, devem ser observadas as seguintes:

- O local de estocagem deve manter uma temperatura constante, ao redor de 20 graus Celsius (± 2);
- As medições de temperatura devem ser efetuadas de maneira constante e segura, com registros escritos;
- Deverão existir sistemas de alerta que possibilitem detectar defeitos no aparelho de ar condicionado para pronta reparação.

Os medicamentos imunobiológicos (vacinas e soros) requerem condições ótimas de estocagem para manterem suas efetividades de uso, especialmente, no que se refere à temperatura. Assim devem ser observadas as seguintes recomendações:

- Manuseio de medicamentos imunobiológicos devem ter prioridade em relação aos demais, bem como sua liberação para entrega;
- Deve ser evitada ao máximo, a exposição desses produtos a qualquer tipo de luz;
- As áreas de estocagem devem ser em equipamento frigorífico, constituído de refrigeradores, freezers e câmaras frias. Termógrafos nas câmaras frias e termômetros de máxima e mínima em refrigeradores e freezers;
- As medições de temperatura devem ser registradas diariamente pelo responsável pela Central de Abastecimento e qualquer anormalidade, prontamente corrigida;
- A distribuição dos medicamentos dentro dos equipamentos frigoríficos deve permitir a livre circulação do ar frio entre as embalagens. Uso de antecâmaras para evitar a perda desnecessária de frio quando da abertura de suas portas;
- As entradas e retiradas de produtos de equipamentos frigoríficos devem ser programadas antecipadamente, visando a diminuir ao máximo as variações internas de temperatura;
- Os equipamentos frigoríficos devem sempre estar ligados a geradores para atender a possíveis faltas de energia;
- Os refrigeradores e freezers devem ser aproveitados para produção de gelo utilizado nas remessas dos produtos e para segurança do próprio equipamento e dos produtos que ele contém numa eventual falta de energia;
- Todos os equipamentos utilizados para este fim devem ser dotados de alarmes que indiquem prontamente qualquer anormalidade no seu funcionamento (MAIA NETO, 2005).

Em razão das características desses medicamentos, sua área de estocagem deve ser considerada de segurança máxima, pois, tais medicamentos precisam estar em local isolado dos demais, somente podendo ter acesso a ela pessoal autorizado pelo farmacêutico responsável da Central de Abastecimento. Os registros de entrada e saída devem ser feitos de acordo com a legislação sanitária específica, sem prejuízo daquelas determinadas pela própria administração (MAIA NETO, 2005).



RESUMINDO

Nesta unidade entendemos que o processo de logística hospitalar é uma teia, ou seja, para que o objetivo seja alcançado, a gestão e a logística devem funcionar em conjunto. Isso traz um impacto positivo para o equilíbrio financeiro da instituição e para a segurança à saúde dos pacientes.

Com as novas tendências tecnológicas na saúde, tudo tende a ser realizado de maneira mais tranquila, através da automatização. Um software ou as ferramentas de gestão tendem a trazer mais segurança que significam mais vantagens para a instituição.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, J.S. Administração de Materiais. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1981.

BALLOU, R.H. Logística Empresarial: Transporte, Administração de Materiais e Distribuição Física. São Paulo: Atlas, 1993.

BARBIERI, J. C., MACHLINE C.; Logística Hospitalar: Teoria e Prática. São Paulo: Saraiva, 2006.

CAVALLINI, M. E.; BISSON, M. P., Farmácia Hospitalar, Um enfoque em sistemas de Saúde, Brasileira. Barueri: Manole, 2002.

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1983.

CHRISTOPHER, M.: Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: estratégias para a redução

de custos e melhoria dos serviços. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

COSTA, J. C. N; GALVÃO, C. R. Gestão de Materiais. In PEREIRA, L. L, GALVÃO, C. R.; CHANES, M {Org.}. Administração Hospitalar. Instrumentos para gestão profissional. São Paulo: Loyola, 2005. DIAS, M.A.P. Administração de Materiais: Uma abordagem logística. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1993. FERRACINI, F. T.; BORGES FILHO M. W. Prática Farmacêutica no Ambiente Hospitalar: do planejamento à realização. São Paulo: Atheneu, 2005.

FLEURY, P. F. Supply Chain Management: Conceitos, oportunidades e desafios de implementação. São Paulo: Atlas, 1999. GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisas. 24 ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GOMES L.P., Informativo Mensal do CRA/CE, CRA em Ação, Ano 1, no. 07/Agosto/Setembro 2005. GOMES, M. J. V. M.; REIS, A. M. M. Ciências Farmacêuticas: Uma Abordagem Hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2000.

Brasil – Ministério da Saúde – Guia Básico de Farmácia Hospitalar, 1994.

KWASNICKA, E. L., Introdução à Administração. 6.^a Ed. São Paulo: Atlas, 2004.

LODI, J. B. História da Administração. 8. Ed. São Paulo: Pioneira, 1984.

MAIA NETO, J. F. Farmácia Hospitalar e suas interfaces com a saúde. São Paulo: RX Editora, 2005. MALIK, A. M. SCHIESARI, L. M. C. Qualidade na gestão local de serviços e ações de saúde. São Paulo: Fundação Petrópolis, 2002.

MARTINS, P. LAUGENI, F. Administração da Produção. São Paulo, 2003.

MAXIMIANO, A. C. A. Teoria geral da administração: da escola científica à competitividade na economia globalizada. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2000.

MONTANA, P.J., CHARNOV B. H.; Administração. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

MORAIS, A. M. P.; Iniciação ao Estudo da Administração. 2. Ed. Revisada. São Paulo: Macro Books, 2001.

NOVAES, A.G. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

PATERNIO, D. A Administração de materiais no hospital: Compras, Almoxarifado e Farmácia. 2. ed. São Paulo: Centro São Camilo de Desenvolvimento em Administração da Saúde, 1990.

PEREIRA, L. L., GALVÃO, C. R.; CHANES, M. Administração Hospitalar Instrumentos para gestão profissional, São Paulo: Loyola, 2005.

VERGARA, S. C. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

Logística Hospitalar

Edmundo Souza



TeleSapiens